厦门市人民政府办公厅文件

厦府办规〔2026〕9号

厦门市人民政府办公厅关于印发《厦门市建立长期护理保险制度实施方案》的通知

各区人民政府，市直各委、办、局，各开发区管委会:

《厦门市建立长期护理保险制度实施方案》已经市委和市政府研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。

厦门市人民政府办公厅

2026年9月29日

（此件主动公开）

厦门市建立长期护理保险制度实施方案

为积极应对人口老龄化，健全完善社会保障体系，满足失能人员长期护理基本保障需求，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快建立长期护理保险制度的意见》，以及《福建省人民政府办公厅关于印发<福建省建立长期护理保险制度实施方案>的通知》（闽政办〔2026〕14号）等规定，结合本市实际，制定本实施方案。

一、目标任务

按照“覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续”的总体要求建立长期护理保险制度。贯彻公平适度、保障基本、尽力而为、量力而行的理念，坚持独立运行、多元筹资、以收定支、收支平衡的原则，落实国家、省部署要求，2027年实现职工居民全覆盖。

二、建立统筹城乡的长期护理保险制度

（一）明确参保范围。本市用人单位（包括企业、事业单位、机关、社会组织）以及其职工、退休人员（指享受本市职工医保退休待遇的人员）、灵活就业人员和未就业城乡居民按属地管理原则参加长期护理保险。

（二）实行市级统筹。建立长期护理保险市级统筹机制，本市行政区域内实行统一覆盖范围、统一筹资政策、统一待遇保障、

统一定点管理、统一经办服务、基金统收统支“六统一”。按国家和省部署要求，配合推进省级统筹。

三、建立稳定可持续的筹资机制

（一）建立合理筹资渠道。长期护理保险保费实行单位、个人、政府、社会等多元筹集机制，基金统一建账、资金统筹使用，与基本医疗保险共同缴费。单位职工由用人单位和职工个人共同按月缴费。鼓励灵活就业人员按单位职工费率标准参保，由个人按规定缴费；灵活就业人员也可选择以未就业城乡居民身份参保缴费。退休人员费率与单位职工个人费率相同，由个人缴费，原用人单位不缴费。未就业城乡居民按年缴费，实行个人缴费和财政补助相结合。18 周岁以下未就业人员跟随父母或法定抚养人等参保，不单独筹资，按规定享受未就业城乡居民长期护理保险待遇。孤儿、事实无人抚养儿童等无法跟从参保的，视同参保。职工基本医疗保险个人账户可以用于本人及近亲属参加长期护理保险的个人缴费。

（二）确定筹集标准。长期护理保险费率统一为 0.3%，缴费基数按参保人员类型分别确定。

1.单位职工。单位职工参保由用人单位和个人按 1∶1 同比例共同缴费，其中，用人单位按其职工工资总额的 0.15%缴费，职工个人按其本人工资收入的 0.15%缴费。工资总额的构成以国家统计局规定为准，缴费基数及上下限按职工基本医疗保险缴费

基数执行。

对原职工基本医疗保险单位费率7.5%进行调整，调整0.15%用作长期护理保险单位费率。调整后，单位缴纳职工基本医疗保险的费率为7.35%。

2.退休人员。由个人缴费，原用人单位不缴费。退休人员按其本人月基本养老金的0.15%缴费，经本人同意，费款可从其职工基本医疗保险个人账户代扣代缴，待条件成熟时，也可由发放基本养老金的社会保险经办机构代扣代缴。

3.灵活就业人员。灵活就业人员参加长期护理保险的类型原则上与基本医疗保险保持一致。已参加职工基本医疗保险的灵活就业人员，按单位职工费率0.3%标准参保缴费的，从职工基本医疗保险费率中调整0.15%，参保人可从职工基本医疗保险个人账户办理个人缴费部分的代扣代缴；缴费基数执行灵活就业人员参加职工基本医疗保险的基数（不低于上年度全省全口径城镇单位就业人员平均工资的60%）。灵活就业人员以未就业城乡居民身份参保的，按未就业城乡居民参保政策参保缴费。

对原灵活就业人员职工基本医疗保险费率9.5%进行调整，调整0.15%用作长期护理保险费率。调整后，灵活就业人员缴纳职工基本医疗保险的费率为9.35%。

4.未就业城乡居民。以上年度城乡居民人均可支配收入为基数。费率利用5年时间逐步过渡到0.3%，建制第一年、第二年费

率为 0.15%，第三年、第四年为 0.2%，第五年为 0.25%，第五年以后年度为 0.3%。财政补助与个人缴费的比例为 1∶1 左右。财政补助部分由市、区财政按城乡居民基本医疗保险结算体制执行。为鼓励大学生参保，个人缴费部分可由财政给予资助。具体筹资标准和资助标准由市医保部门会同财政部门确定。

5.困难群众。符合条件的困难群众个人缴费部分，由财政分类资助，资助对象和资助标准参照医疗救助资助参保的有关规定执行，困难大学生参照城乡居民基本医疗保险资助政策执行。

四、实施公平适度保障

（一）合理确定保障对象。按规定参保缴费且失能状态长期持续（一般为 6 个月以上），经申请通过评估认定的失能人员。长期护理保险制度起步阶段保障重度失能人员。若国家扩大保障对象范围，则从其规定。

（二）合理确定待遇保障标准。落实国家长期护理保险基准待遇标准，根据服务方式适度实行差别化待遇保障政策；条件成熟时，可根据失能等级适度实行差别化待遇保障政策。

1.起付标准。长期护理保险待遇享受不设起付标准。

2.支付比例。依据缴费标准不同，待遇标准分职工和居民两类设置。符合规定的长期护理服务费用，由长期护理保险基金按比例支付。选择居家护理或社区护理的，职工、居民参保人员基金支付比例分别为 75%、55%；选择机构护理的，职工、居民参保

人员基金支付比例分别为 70%、50%。具体支付标准由市医保部门会同财政部门确定，并根据本市经济发展水平和基金运行情况实行动态调整。

3. 最高支付限额。参保人员年度内基金最高支付限额不超过上年度本市城乡居民人均可支配收入的 50%。

（三）严格执行基金支付范围。长期护理保险基金主要用于支付符合规定的长期护理服务机构和人员提供长期护理基本服务所发生的费用，以及符合规定的失能等级评估和引入社会力量参与经办的服务费用。原则上不得直接向失能人员发放现金。

1. 严格执行国家统一的长期护理保险服务项目目录。按国家和省统一部署，探索将支持性辅助器具、智能化服务等逐步纳入支付范围。

2. 根据国家和省统一部署，做好长期护理保险与经济困难的高龄、失能老年人补贴及重度残疾人护理补贴等政策的衔接。领取工伤保险生活护理费的参保人员，不重复享受长期护理保险相关服务待遇。

3. 下列费用不纳入长期护理保险基金支付范围:

（1）机构床位费、膳食费等非护理服务费用;

（2）不符合规定的长期护理服务机构、评估机构和人员提供服务的费用;

（3）应由医疗保险支付的医疗费用;

（4）应由第三方依法承担的护理费用;

（5）在境外发生的护理费用;

（6）法律法规和国家、省政策规定的其他不予支付的费用。

4.享受长期护理保险待遇的参保人员出现下列情形之一的，终止或中止待遇享受:

（1）参保人员死亡的;

（2）经重新评估不再符合待遇享受条件的;

（3）参保人员中止参保或中断缴费的;

（4）住院治疗期间;

（5）法律法规和国家政策规定终止或中止待遇享受的其他情形。

（四）落实激励约束机制。执行国家和省参保激励约束机制相关规定。

五、建立健全管理服务体系

（一）规范评估管理，落实评估服务费分担机制。落实全国统一的失能等级评估标准，执行全省统一的失能等级评估服务费分担政策。长期护理保险失能等级评估机构实行定点管理，支持发展专业独立的社会化评估机构，建立健全评估人员规范化培训机制，统筹利用现有评估认定力量，鼓励发挥家庭医生在失能等级评估中的作用。综合考虑失能人员总体规模、评估行业发展实际、管理服务能力等，合理确定本市定点评估机构数量。推动建

立评估结果跨部门互认互用机制，有关部门按需使用。

（二）加强服务管理，完善支付机制。长期护理服务机构实行定点管理，市医保部门根据参保人员长期护理服务需求、长期护理保险基金收支、长期护理服务资源等情况，统筹规划本市定点长期护理服务机构的配置。加快推进长期护理服务人员队伍建设，建立长期照护师培养培训机制，规范提升服务质量，落实培训补贴和职业技能评价补贴。按国家和省部署建立健全基金支付管理机制，针对不同服务方式，完善按床日、按服务时长等支付方式。完善长期护理保险服务质量评价和监督制度，健全费用控制激励约束机制。

（三）严格基金管理，强化基金监管。长期护理保险基金纳入社会保险基金财政专户管理，单独建账、单独管理、专款专用。提高长期护理保险基金管理水平，科学编制基金收支预算，强化预算执行监控和绩效评价。在长期护理保险基金出现支付困难时，由市医保部门会同财政部门按规定及时调整筹资和待遇政策。建立健全长期护理保险监管体系，规范基金使用，完善对欺诈骗保人员、机构的惩戒机制，做好协议管理与行政监管衔接，发现涉嫌欺诈骗保的依法依规查处；涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

（四）优化经办服务，加强数据共享。加强定点评估机构和服务机构协议管理，规范机构行为。依法依规通过公开招标等竞

争性方式有序规范引入第三方社会力量参与经办管理服务，相关费用依协议约定从长期护理保险基金中支付，完善对参与经办的第三方机构的考核评价，不得将基金交由受托经办业务的第三方机构代管代拨。根据国家和省部署做好跨统筹区长期护理保险关系转移接续工作，贯彻落实国家和省异地参保、异地享受待遇的政策规定。加强长期护理保险信息化建设，强化全国统一的医保信息平台长期护理保险子系统功能应用，实现医保、税务、公安、民政、卫健、人社、残联等部门相关信息共享，推进长期护理保险待遇享受人“一人一档”数字化管理。

（五）强化服务供给，培育长护市场。大力发展和培育社会化长期护理服务市场。加强居家社区长期护理服务供给，倡导居家社区护理；支持基层医疗机构整合资源，利用闲置床位提供长期护理服务。积极引导农村转移劳动力和家政服务人员参与长期照护师培训。鼓励具备条件的各类职业院校培养长期照护师，提高长期护理服务质量。支持信息化、智能化技术与长期护理服务融合。鼓励商业保险公司开发与长期护理保险相衔接的商业补充保险产品，满足参保群众多样化、多层次的护理保障需求。

（六）统筹协同推进，落实责任分工。各级各有关单位落实部门职责分工，强化部门联动，共同推动长期护理保险制度建设。医保部门牵头组织实施长期护理保险制度；财政部门会同有关部门做好基金预决算管理，落实财政补助政策；民政部门推动养老

服务体系建设，引导各类养老照料机构转型发展居家上门照护服务，做好失能老年人补贴政策的衔接和老年人能力评估结论的数据共享工作；人社部门配合主管部门推动开展长期照护师职业技能培训和评价工作，引导长期护理服务机构完善与技能等级相适应的薪酬分配制度，做好与工伤保险政策的衔接，做好工伤保险和退休人员养老金相关数据共享，配合推进退休人员保费代扣代缴工作；卫健部门引导基层医疗机构等参与长期护理服务，对提供长期护理服务的医疗机构进行医疗行业管理和监督，支持和鼓励医疗机构医护人员参与失能等级评估工作，做好长期护理保险待遇人员就医诊疗数据共享；税务部门建立完善征缴机制，按时足额征收保费，优化参保缴费服务；农业农村部门负责做好防止返贫致贫对象认定和帮扶工作；残联协同做好残疾人参保相关工作，积极配合民政部门做好重度残疾人护理补贴对象的审核认定工作；市场监督管理部门依职责对提供长期护理服务的机构经营行为进行监管；金融监管部门做好参与经办的商业保险机构市场行为的监管，引导和规范与长期护理保险相衔接的商业补充保险发展；各区人民政府支持经办机构和服务网点建设，配合做好长期护理保险相关工作。

六、组织保障

各级各部门要加大政策宣传力度，凝聚社会共识，营造良好氛围。坚持正确舆论导向，妥善回应公众关切，强化互助共济理

念，合理引导预期。坚持系统观念，确保全市长期护理保险制度平稳有序实施。实施过程中因经济社会发展水平、基金收支结余情况、服务成本变化等因素，需进行政策调整的，由市医保部门会同财政部门报市政府同意后按规定程序报省医保局和省财政厅审核。

本实施方案自发布之日起施行，有效期 5 年。实施过程中国家、省对长期护理保险政策进行调整的，从其规定。

厦门市人民政府办公厅　　2026年9月30日印发